

31. 어지럼

● **중요 포인트**

- 1. 전정성/비전정성, 말초성/중추성 구별해 적절한 진단 및 치료 계획 수립
- 2. 응급치료가 필요한 환자 감별

● **Overview**

- 1. **문진:** 어지럼의 양상, 동반증상 등을 자세히 문진하나 시간이 부족할 수 있는 항목이기 때문에 시간배분이 중요
- 2. **신체진찰:** Dix-hallpike 검사, Head impulse 검사, Romberg 검사 등 어지럼증을 감별하기 위해 수행해야 되는 검사법 시행 필요. 신체 진찰에서 해야할 것들이 많기 때문에 병력 청취를 어느 정도 하고 난 다음에는 신체 진찰을 하면서 물어보는 것이 좋을지도
- 3. **환자교육:** 어지럼은 대개 호전되는 경우가 많으니 안심시켜 주고, 어지럼이 나타날 때 안전한곳에서 휴식을 취해 2 차 외상을 방지하도록 주의
- 4. **감별진단:** --

● **평가 목표**

평가목표			
1) 전정성/비전정성, 말초성/중추성 구별해 적절한 진단 및 치료 계획 수립			
2) 응급치료가 필요한 환자 감별			
구체적인 성과			
병력 청취	어지럼의 특징(회전성)	회전성: 전정기관/소뇌 문제 빙글빙글 ▢ BPPV, 전정신경염, 메니에르병, 소뇌경색, 전정편두통, 뇌종양	비회전성: 전신 내과/신경계 퇴행 문제 아찔함 ▢ 기립저혈압, 혈관미주신경실신 전신 무력감, 식은땀, 안색 창백 ▢ 빈혈/저혈당 붕 떠있거나 세상이 흔들리는 느낌 ▢ 불안장애
		지속 시간: 초 단위 ▢ BPPV 분~시간 단위 ▢ 메니에르 수일 이상 ▢ 전정신경염/뇌경색	
	어지럼의 동반증상(구토 등)	동반 증상: 신경학적 결손(복시, 마비, 보행 장애) ▢ 중추성 (Brain CT/MRI 필수) 청각 증상(이명, 난청) ▢ 말초성 (메니에르 등)	
	어지럼의 유발 요인	유발 요인: 특정 자세(BPPV), 기립 시(저혈압), 스트레스(실신/불안).	
	환자/의사관계		
신체 진찰	신경계 이상 확인하기 위한 신경진찰 원인 감별을 위해 필요한 신체진찰	VS 확인, 두부외상, 눈/입(빈혈/탈수) 뇌신경검사 청력검사 소뇌검사 Dix hallpike 사지감각/운동검사	
	필수 임상술기	이경검사 혈압측정 안저검사	
	환자/의사관계	환자 부족해주기! 손잡아주기! 기댈 수 있게 해주기!	
진단 및 치료	신경계질환 및 기타 원인에 의한 어지럼 진단계획	전정기능검사 중 하나가 비디오안진검사 “특수한 카메라 달린 안경쓰고 눈 움직임 기록, 어지럼증 귀/뇌에서 오는지 파악” 기립경검사: 누운 상태에 비해 일어선 상태의 혈압 20/10 이상 차이 귀검사: 청력/이경검사 영상: 뇌 CT, MRI 혈액검사: 혈당, 전해질, 전해질	
	응급치료가 필요한 환자를 선별하고 치료계획 수립	소뇌경색 등 뇌졸중, 저혈당, 심한 저혈압/쇼크	
	원인 질환의 치료 계획 수립	양성돌발체위현기증	에플리 수기/이석정복술

		BPPV	
		전정신경염	BZD, 항구토제, 전정 재활운동 경과관찰
		메니에르병	저염식, 이뇨제, 항구토제 급성기 □ Diphenhydramine(항히스타민제), Diazepam(안정제/항구토제) 장기 □ Thiazide, 내림프낭감압술
		소뇌경색 *응급	혈전용해제/혈전제거술, 항혈소판제, 항응고제, 뇌감압술
		파킨슨병	Levodopa+Carbidopa, Dopamine agonist 재활치료
		전정편두통	급성기 □ NSAID Triptan 제제(편두통 약)
		뇌종양	방사선치료 항암치료 수술 감마나이프
		기립저혈압	유발 약제/인자 중단 움직이기 전에 다리를 먼저 움직이고 천천히 일어나기 Midodrine(말초혈관수축제) 수분섭취
		저혈당	당류 공급(D5W, 사탕) Insulin dosage 조절
		빈혈	철분 보충
		당뇨병신경병증	혈당조절, 생활습관개선
		혈관미주신경실신	유발 인자 중단/회피 Midodrine(말초혈관수축제)
		불안장애	SSRI, BZD, 인지행동치료
		과호흡증후군	SSRI, BZD, 재호흡 주머니
환자 교육	응급치료가 필요한 환자에게 수술의 필요성 설명	"검사 결과, 환자분의 어지럼증은 귀의 문제가 아니라 뇌(소뇌/뇌간)의 혈관이 막혔거나(뇌경색) 터진(뇌출혈) 상태로 확인되었습니다. 이는 생명과 직결될 수 있는 응급 상황이며, 즉각적인 조치가 이루어지지 않으면 뇌 손상이 급격히 진행될 수 있습니다." 뇌경색 □ 혈관 뚫어줘서 뇌손상 방지, 마비 보행장애 후유증 최소화 뇌출혈/뇌압상승 □ 고인 혈종 제거하거나 뇌압 낮추는 수술 필요	
	생활습관 개선 교육	스트레스, 과로, 피로 불면 해결	
	말초성 어지럼 비약물 치료	메니에르병 저염식 권장, 술, 커피, 담배, 스트레스 피하기 어지럼이 발생해 쓰러질 것 같으면 안정된 곳으로 몸 옮겨 머리를 다치지 않도록 조심	
	중추성 어지럼 대처 방법	BPPV 는 병원에서 치료받고 난 후 상체 약 45 도 높은 자세로 하루 정도 쉬기 혈당관리, 빈혈치료, 수분 적절히 섭취	

● 원인 질환 정리

질환	질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
양성돌발체위현기증 BPPV 4+1	귀속의 작은 돌(이석)이 제자리를 벗어나 굴러다니는 병	고개를 특정 방향으로 돌리거나/침대에서 일어날 때 발생 한번에 30 초 정도 심하게 지속 빙글빙글 도는 느낌 = 회전성 아침에 심하고 오후에 경해짐 오심/구토 Dix-hallpike test 안진/어지럼 +/-		Dix-hallpike test, 전정기능검사, 머리회전검사	에플리 수기/이석정복술
전정신경염 2+1	전정신경(평형 담당)에 염증이 생겨 한쪽 기능이 마비되는 질환	급성 발병, 수 시간~수 일 지속 최근 상기도 감염 선행 오심/구토 난청/이명 없음 빙글빙글 도는 느낌 = 회전성 자발안진 +, 두부충동검사 병변쪽 +		전정기능검사, 청력검사	BZD, 항구토제, 전정 재활운동 경과관찰
메니에르병 3+1	귀 안쪽의 내림프액이 과도하게 많아지는 '내림프 수종'이 원인 귀속의 압력이 높아지며 생김	20 분에서 수시간 지속 회복, 반복적으로 재발 빙글빙글 도는 느낌 = 회전성 이명, 청력 저하, 이충만감		청력검사, 전정기능검사, 전기와우도검사, 두경부 CT/MRI	저염식, 이뇨제, 항구토제 급성기 Diphenhydramine(항히스타민제), Diazepam(안정제/항구토제) 장기 Thiazide, 내림프낭감압술
소뇌경색*응급 0+1	뇌로 가는 혈관이 막혀 조직이 손상되는 질환	급성 발병, 고령 지속시간 다양, 가만히 있어도 어지럼 빙글빙글 도는 느낌 = 회전성 심한 자세 불균형, 편측마비, 구음장애, 감각이상 고혈압, 고지혈증 과거력		뇌 CT/MRI, 뇌혈관조영술	혈전용해제/혈전제거술, 항혈소판제, 항응고제, 뇌감압술
파킨슨병	도파민 부족으로 인해 자세 유지 반사가 소실되는 퇴행성 질환	손떨림, 행동 느려짐, 균형장애, 보행장애		뇌 CT/MRI, 뇌 PET	Levodopa+Carbidopa, Dopamine agonist 재활치료
전정편두통	뇌의 통증 및 감각 조절 이상으로 인해 편두통과 함께 어지럼이 발생하는 질환, 빛이나 소리에 예민	수 시간 지속되는 어지럼 동시에 편두통에 합당한 두통 발생 빙글빙글 도는 느낌 = 회전성		-	급성기 NSAID Triptan 제제(편두통 약)
뇌종양	뇌에 종양	두통, 오심, 구토 체중감소 빙글빙글 도는 느낌 = 회전성		뇌 CT/MRI, 뇌 PET	방사선치료 항암치료 수술 감마나이프
기립저혈압	갑자기 일어날 때 하반신에 쏠린 혈액이 뇌로 충분히 전달되지 않아 발생	앞았다 갑자기 일어서는 상황 눈 앞이 깜깜해지는 느낌 아절함 최근 출혈 또는 탈수 병력 탈수 증상 고혈압 과거력		누운 상태에 비해 일어난 상태의 혈압 20/10 이상 차이 = 기립경 검사	유발 약제/인자 중단 움직이기 전에 다리를 먼저 움직이고 천천히 일어나기 Midodrine(말초혈관수축제) 수분섭취
저혈당*응급	혈중 포도당 농도가 급격히 낮아져 뇌	식은땀, 두근거림 동반 오랜 공복 후 발생, 당뇨병으로 인한 인슐린 사용		혈당검사	당류 공급(D5W, 사탕) Insulin dosage 조절

	에너지가 고갈된 상태	아찔한 양상		
빈혈	혈액 내 헤모글로빈 부족으로 뇌에 산소 공급이 원활하지 못한 상태	흑색변, 혈변, 피로 동반 아찔한 양상 식은땀	전혈구검사	철분 보충
당뇨병신경병증	고혈당으로 인해 발끝의 말초 신경이 손상되는 합병증	당뇨 병력, 조절되지 않는 당뇨 말초감각이상, 위마비 동반 가능	혈당검사, 당화혈색소, 자율신경검사	혈당조절, 생활습관개선
혈관미주신경실신	스트레스나 통증에 의해 부교감신경이 과하게 활성화되어 혈압과 심박수가 급락하는 현상	오래 서있거나/과하게 긴장하거나/혼잡한 환경에서 발생 아찔함 + 메스꺼움	기립경 검사	유발 인자 중단/회피 Midodrine(말초혈관수축제)
불안장애	심리적 불안으로 인해 뇌의 자율신경계가 과민해진 상태	불안하거나 가슴이 답답하면서 어지럼 발생 붕떠있거나 세상이 흔들리는 느낌		SSRI, BZD, 인지행동치료
과호흡증후군	불안 등으로 숨을 너무 빠르고 깊게 쉬어 체내 이산화탄소가 부족해지는 상태	스트레스 등의 유발 요인으로 과호흡 후 어지럼 발생 손발 저림		SSRI, BZD, 재호흡 주머니

● 대본

자기소개/환자확인/환자동의/활력징후		
"진료 대기 시간이 길었는데 오래 기다리시느라 고생 많으셨습니다./몸도 좋지 않은데 병원까지 오셔서 기다리시느라 고생이 많으셨습니다."		
O	언제부터 갑자기/서서히 특정 상황	
L	-	
D	지속/있다 없다 얼마나 자주 얼마나 오래	
Co	악화/유지	
Ex	이전에도? □ 치료	
C	개방형: "어떻게 어지러운지 자세히 설명해주시겠어요?" 양상: 빙빙/아찔 정도: -서있기힘듦/쓰러진적/의식잃은적/가만있을때 -얼마나 심한지: QoL □ "많이 힘들었습니다."	
A	개방형: "다른 불편한 곳은 없으세요? 네. 그럼 제가 몇가지 자세하게 확인해보겠습니다." 암기법: 응전전저정 소소메편 (응급/전신/전정신경/저혈당/정신/소뇌/소화기/메니에르/편두통) 또다른 암기법: 응전 정호귀신 (응급/전신/정신/호흡/귀/신경) 응 전 소 신경 감기 귀 파 정신	
	전신	Fever/Chill Fatigue/Anorexia WL/Edema
	응급(탈수/빈혈)	호흡곤란/어지럼/두근거림/목마름 토혈/객혈/혈변/월경량증가
	저혈당	공복감, 식은땀, 식후회복
	소뇌경색	시력저하, 시야/발음/보행장애, 팔다리 감각/근력저하
	전정신경염	최근 감기, 발열/기침/가래/콧물
	메니에르병	귀물참/귀통증, 이명/청력감소
	정신	우울/불안/공황
	편두통	두통 □ 전조증상(시아흐림/번쩍, 빛소리와민, 맥박성)
F	개방형: "증상이 어떨 때 좀 괜찮아지고/심해지나요?"	
	식사	식후 호전 -저혈당
	자세	고개 돌릴 때/돌아 누울 때(어느쪽) 앉았다 누울 때/일어설 때 -기립성 저혈압 가만히 있어도
E	건강검진 + 예방접종 + 감기	
요약 및 PPI	"지금까지 말씀하신 것을 요약하자면 ~." "제가 질문을 많이 했는데 잘 대답해주셔서 감사합니다. 몇가지만 더 여쭙도록 하겠습니다."	
외	수술/두부외상	
과	HTN/DM/고지혈증/심뇌혈관질환/정신과	
약	약물/영양제/한약/즙 약 증량/변경	
사	술/담배/커피/직업/스트레스	
가	CC 심뇌혈관질환(뇌졸중)	
여	월경력: LMP □ 규칙성/양	
요약 및 PPI	"네. 이로써 문진은 마치도록 하겠습니다." "혹시 더 말씀해주시고 싶은 것 있으실까요? 편하게 말씀해주세요."	

환자동의 “정확히 어디가 아픈지 확인하기 위해 신체진찰을 진행해야 합니다. 과정 중에 신체 노출과 접촉이 있을 수 있으나, 불편하시지 않게 필요한 부분만 노출하고 최대한 신속히 확인하겠습니다. 괜찮으실까요? 중간중간 불편하시면 언제든지 말씀해주세요.”		
기본 신체진찰	VS 확인, 두부외상, 눈/입(빈혈/탈수)	
신경계	자세	침대에 앉아서 진행, 환자 부축해주기
	뇌신경	자발안진 “제 코 보세요.” □ HIT “고개 고개돌려도 제 코 보세요.” □ 동공반사 □ 안구운동검사: 천천히 8 방향 -> 감각검사: 눈감고 휴지/해머 이마/볼/턱 “느껴지시나요/동일한가요” 운동검사: “눈 꼭 감아보세요” □ 눈 벌러지는지 “이 꼭 깨물어보세요” □ 턱 근육 만지기 “이 해보세요/이마 주름 만들어보세요”
	팔다리	감각검사: 눈감고 휴지/해머 위팔/아래팔/허벅지/종아리 “느껴지시나요/동일한가요” 운동검사: 팔 거드랑이 들고 흔드는 자세 □ 위아래 버티기 가드 자세 □ 앞뒤 밀기 허벅지 씨름 □ 벌리기/모으기 종아리 잡고 차기/뒤로 당기기 DTR: Biceps 엄지손가락쪽(팔바깥쪽) 안에 두드리기 □ 오른손으로 팔꿈치 잡으면서 팔 지탱+힘줄부분 엄지로 눌러 오른엄지로 누른 부분 위를 해머로 치기 무릎 한손으로 허벅지 눌러서 고정 □ 다른손으로 두드리기 +Babinski) 해머 뒤로 발바닥 안쪽부터 새끼까지 긁고 다시 엄지 쪽으로 들어서 긁는 ㄱ자 모양 긁기
	수막자극 징후	누워서 [Kernig] 바로 누워서 □ 무릎/발목 잡아주고 ㄱ자로 위로 들어올리며 무릎 펴기 [Brudzinski + Neck stiffness] 바로 누워서 □ 목 들어올리기 □ 엉덩이/무릎 들림 = B (+) 다리 ㄴ자로 세우고 □ 목 들어올리기 □ 통증 호소 = N (+)
청력검사	Weber	머리 중앙에 진동을 대고 어느 쪽에서 더 크게 들리는지 여쭙볼게요. “어느 쪽에서 더 크게 들리세요?” “양쪽이 똑같이 들리세요?” 결과 해석: 정상 = 가운데에서 들림, 전도성 난청 = 병변 쪽으로 소리 치우침 (막힌 귀가 더 크게 들림) 감각신경성 난청 = 정상 쪽으로 소리 치우침 (신경 정상인 쪽 더 잘 들림)
	Rinne	골전도(BC) 튜닝포크를 귀 뒤 유양돌기(mastoid)에 댄 □ “소리 들리세요?” □ “안 들릴 때 말씀해주세요” 2 안 들린다고 하면 바로 공기전도(AC) 튜닝포크를 귀 앞(외이도 앞)으로 이동 □ “지금도 들리세요?” 결과 해석: 정상/감각신경성 난청 = AC > BC → 린네 양성 전도성 난청 = BC > AC → 린네 음성
	Ménière disease (내이질환), Labyrinthitis (내이+전정 침범) → 감각신경성 난청 Vestibular neuritis (전정만 침범), BPPV (이석문제) -> 난청없음 중이질환 -> 전도성 난청	
소뇌	[앉아서] Finger to nose : 코에 손 댔다가 제 손가락 찍기 □ 양손+원/우/중앙 Rapid alternating : 허벅지에 손 올리고 열라뒤집기	[서서] Tandem/ Romberg : 일단 한번 걸어보세요 □ 돌아올 땐 앞발 발가락 끝에 다음발 뒷꿈치 붙여서 걸어요 □ 양발 앞꿈치 뒷꿈치 다 붙여서 서 눈감아보세요 (팔 환자 주변으로 뻗어서 보호)
Dix hallpike	침대 다리 편 상태로 앉으면 머리 45도로 돌린 다음에 확 빠르게 눕힘 많이 어지러울 수 있다 경고 필요	



[Dix-Hallpike test]



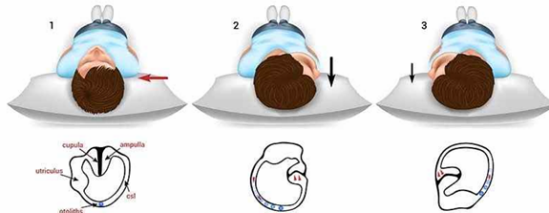
[Head thrust test]

* Supine rolling test (lat, semicircular에 이석 있는 것) (Dix-hallpike + 면 post.에 이석)
머리를 바닥에 대고 누운 채로 고개를 좌우로 돌려보는 것
→ 해석: 땅쪽이나 천장쪽으로 안진이 뛰면 lat.에 이석 있음

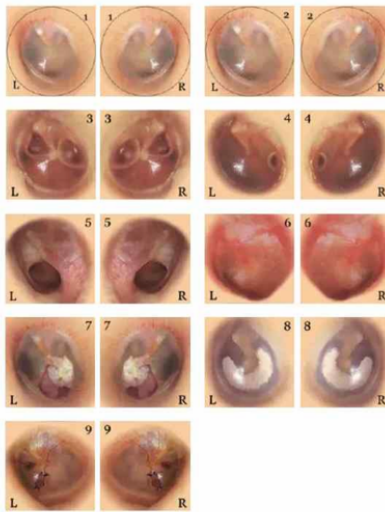
* Head thrust test
가만히 앉은 상태에서 머리를 양손으로 잡고 흔든 뒤 눈 관찰
→ 해석: 정면 주시 못하면 vestibular neuritis (병변 쪽으로 고개를 돌렸을 때)
주의 SP 환자가 놀라거나 다칠 수 있으니 반드시 세게하지 않도록 주의합니다.

* 가만히 앉은 상태에서 안진 관찰되면 vestibular neuritis (or cerebellar infarction)
→ 해석: Rt.로 뛰면 Lt. 전정신경 분절/Lt.로 뛰면 Rt. 전정신경 문제

DETERMINATION OF THE AFFECTED SIDE IN THE
PAGNI-McCLURE TEST (ROLL-TEST) FOR CANALITHIASIS



이경검사



Cases

Ears: 22 (11 matching sets of right and left)

1. normal
2. normal (large external auditory canal)
3. serious otitis media; SOM
4. mucoid otitis media; MOM
5. chronic suppurative otitis media; CSOM
6. acute suppurative otitis media; AOM
7. cholesteatoma
8. tympanosclerosis
9. traumatic perforations
10. cerumen block
11. practice of foreign substance removal (no eardrum image)



A pair of ear models without eardrums (#11) are prepared for foreign body removal practice with include small toys and simulated earwax.

진찰 과정과 주의사항

검사 전 환자/의사의 준비

1. 환자에게 인사를 하고, 자신의 소속과 신분, 이름을 밝힌 후, 환자의 이름과 주력병력(혹은 방문 발원)을 확인하고 환자에게 이경검사를 하겠다고 말한다.
2. 의사는 손을 씻는다.
3. 환자에게 머리를 검사하는 쪽의 반대편으로 돌리도록 한다.
4. 환자 머리의 높이가 의사의 눈보다 약간 낮도록 의자 높이를 조정한다.

검사 전 이경 준비

5. 이경의 전원 스위치를 켜고 불빛의 밝기를 확인한다.
6. 적당한 크기의 귀별(ear speculum)을 선택하여 골을 일국음 속으로 소독한 후 잘 고정시킨다.

귀바퀴 진찰

7. 귀바퀴와 주변 조직을 시진하여 기형, 결어, 피부 병변에 대해 살핀다.
8. 통증이나 부피, 열증의 소견이 있다면 귀바퀴를 위아래로 당기거나 눌러 보며 확인한다.

바깥귀도관과 고막 진찰

9. 오존족 컵을 검사할 때는 의사가 왼손의 엄지와 검지 손가락을 이용하여 귀바퀴의 앞을 잡고 가운데손가락을 귀바퀴의 후면으로 대고, 뉘는 손가락이나 새끼 손가락을 귀바퀴에 고정된 후 귀바퀴를 약간 바깥쪽으로 잡아당긴다.



그림 5-1

10. 이경을 넣는다고 말하고 움직이지 않도록 환자에게 주의를 준다. 바깥귀도에 부드럽게 진입시키면서 바깥귀도를 시진하여 통증을, 아픔, 발적, 양이 들어 있는지 살핀다.



그림 5-2



그림 5-3

- 이경 넣는 법은 연골을 뒤로 밀어내고 후두골을 뒤로 밀어내어 바깥귀도의 뼈에 대해 고정시키는 방법과 한 손으로 연골을 잡고 다른 한 손으로 연골을 밀어내어 바깥귀도의 뼈에 대해 고정시키는 방법 두 가지가 있다.

- 이경의 끝이 바깥귀도에 직접 닿으면 통증을 유발할 수 있으므로 주의한다.

- 이경을 바깥귀도에 넣을 때 이가 안으로 들어갈 수 있으므로 조심하여 고막이 안으로 들어가지 않도록 주의한다.

- 귀는 방패가 되지 않는 다면 그대로 둔다.

Ménière disease

대개 정상 고막 (내이질환 = endolymphatic hydrops)

	Vestibular neuritis	대개 정상 고막 (전정신경염증이라 중이/고막 병변 없음)
	Labyrinthitis	대개 정상 고막 (단, 중이염에서 파급된 경우는 중이염 소견 동반 가능)
	AOM (acute otitis media)	고막 발적/팽윤, 중이 삼출/고름
	OME (otitis media with effusion)	탁한 고막, 공기-액체층, 후퇴(retraction), 움직임 감소 등 비정상
	COM (chronic otitis media)	고막 천공, retraction, 혼탁/두꺼운 고막 cholesteatoma 가능, 만성 분비
혈압측정		
안저검사		

진단검사	
전정기능검사 중 하나가 비디오안진검사 “특수한 카메라 달린 안경쓰고 눈 움직임 기록, 어지럼증 귀/뇌에서 오는지 파악”	
기립경검사: 누운 상태에 비해 일어선 상태의 혈압 20/10 이상 차이	
귀검사: 청력/이경검사	
영상: 뇌 CT, MRI	
혈액검사: 혈당, 전혈구, 전해질	
치료	
양성돌발체위현기증 BPPV	에플리 수기/이석정복술
전정신경염	BZD, 항구토제, 전정 재활운동 경과관찰
메니에르병	저염식, 이뇨제, 항구토제 급성기 □ Diphenhydramine(항히스타민제), Diazepam(안정제/항구토제) 장기 □ Thiazide, 내림프낭감압술
소뇌경색 *응급	혈전용해제/혈전제거술, 항혈소판제, 항응고제, 뇌감압술
파킨슨병	Levodopa+Carbidopa, Dopamine agonist 재활치료
전정편두통	급성기 □ NSAID Triptan 제제(편두통 약)
뇌종양	방사선치료 항암치료 수술 감마나이프
기립저혈압	유발 약제/인자 중단 움직이기 전에 다리를 먼저 움직이고 천천히 일어나기 Midodrine(말초혈관수축제) 수분섭취
저혈당	당류 공급(D5W, 사탕) Insulin dosage 조절
빈혈	철분 보충
당뇨병신경병증	혈당조절, 생활습관개선
혈관미주신경실신	유발 인자 중단/회피 Midodrine(말초혈관수축제)
불안장애	SSRI, BZD, 인지행동치료
과호흡증후군	SSRI, BZD, 재호흡 주머니
교육	
“무엇이 가장 걱정되세요?”	
안심	
□ 진단/감별진단/설명(그림)	
□ 검사: 혈액검사(혈당/전혈구/전해질) 영상(뇌 CT/MRI) 청력/이경검사 기립경검사 전정기능검사	
□ 치료/응급(뇌출혈/뇌경색 수술 필요)(출혈/의식저하/새로운증상/악화되는증상)	
"검사 결과, 환자의 어지럼증은 귀의 문제가 아니라 뇌(소뇌/뇌간)의 혈관이 막혔거나(뇌경색) 터진(뇌출혈) 상태로 확인되었습니다. 이는 생명과 직결될 수 있는 응급 상황이며, 즉각적인 조치가 이루어지지 않으면 뇌 손상이 급격히 진행될 수 있습니다."	

뇌경색: 혈관 뚫어줘서 뇌손상 방지, 마비 보행장애 후유증 최소화

뇌출혈/뇌압상승: 고인 혈종 제거하거나 뇌압 낮추는 수술 필요

▣ 교정회피

스트레스, 과로, 피로 불면 해결

메니에르병 저염식 권장, 술, 커피, 담배, 스트레스 피하기

어지럼이 발생해 쓰러질 것 같으면 안정된 곳으로 몸 옮겨 머리를 다치지 않도록 조심

BPPV 는 병원에서 치료받고 난 후 상체 약 45 도 높인 자세로 하루 정도 쉬기

혈당관리, 빈혈치료, 수분 적절히 섭취

▣ 질문?